العودة إلى الموقع الرسمي / الأبحاث

YK7 | ملف علمي تحليلي موسع

# الإيحاء والخوف في علم النفس: من التوقع الذهني إلى الاستجابة السلوكية

مراجعة سردية للأدبيات

إعداد: د. ياسر سيد عبد السلام قطب · 12 نوفمبر 2026

---

الصفة المنهجية: مراجعة سردية تحليلية للأدبيات، وليست دراسة تجريبية أو مراجعة منهجية شاملة. الأمثلة افتراضية ما لم يُذكر خلاف ذلك.

# الملخص

نتناول هذه الورقة العلاقة بين الإيحاء النفسي والخوف باعتبارها علاقة متعددة المسارات لا تفسرها سببية أحادية. فقد ينشأ الخوف عن تهديد مباشر، أو خبرة مؤلمة، أو ملاحظة استجابة الآخرين، أو تلقي معلومات عن خطر محتمل. وقد يؤثر الخوف القائم في الانتباه والتقييم والتذكر، فيجعل بعض الرسائل التهديدية أكثر حضورًا، من غير أن يعني ذلك أن الخوف يجعل كل إنسان أكثر قابلية للإيحاء بالضرورة. وتناقش الورقة الضبط المفاهيمي، وآليات التعلم، والتأثيرات الاجتماعية والعصبية، والنوسيبو، والعلاقات الإنسانية، ومعايير التحقق من الخطر، وتقترح إطارًا إجرائيًا رباعيًا ضمن YK7 للفصل بين الحدث وتفسيره والاستجابة له والتحقق من أدلته. لا تمثل هذه الورقة دراسة سريرية أو تشخيصًا، ولا تُسقط احتمال الخطر الواقعي.

الكلمات المفتاحية: الإيحاء، القابلية للإيحاء، الخوف، القلق، التوقع، التعلم بالملاحظة، النوسيبو، التقييم المعرفي، جودة القرار.

## 1. إشكالية البحث وأهدافه

السؤال المركزي ليس: «هل يصنع الإيحاء الخوف؟» فقط، بل: «متى تنقل المعلومات توقعًا بالخطر فينشأ الخوف، ومتى يكون الخوف السابق عاملًا مؤثرًا في قبول الرسالة وتفسيرها؟». وإضافة إلى ذلك، ينبغي سؤال: ما الأدلة التي تسمح بالتفريق بين التحذير الواجب والتخويف المبالغ فيه؟

تهدف المراجعة إلى: تحديد المفاهيم دون الخلط بينها، وشرح مسارات اكتساب الخوف، وتفكيك العلاقة التبادلية الممكنة، ومناقشة التطبيق في العلاقات والصحة والمؤسسات والإعلام، وتقديم ضوابط نقدية تمنع توظيف الإيحاء لتبرير إنكار الضرر الحقيقي.

المنهج مراجعة سردية انتقائية لمصادر أكاديمية ومؤسساتية محددة. وهي ليست بحثًا ميدانيًا، ولا يوجد فيها بروتوكول بحث شامل، أو تقدير مستقل لجودة جميع الدراسات، أو استنتاجات سببية جديدة.

## 2. الضبط المفاهيمي: الإيحاء والخوف والقلق

الإيحاء هنا تأثير محتمل للرسائل أو التعليمات أو سياق التواصل في استجابات الفرد وتوقعاته؛ ولا يعني الاستحواذ على العقل أو تعطيل الإرادة. أما القابلية للإيحاء فهي سمة أو حالة تتعلق بدرجة التأثر برسائل الآخرين، وتتباين باختلاف السياق والمهمة والخصائص الفردية؛ ولا يجوز معاملتها كتشخيص لضعف الشخصية.

التوقع اعتقاد استباقي بشأن ما قد يحدث، وقد يستند إلى معرفة صحيحة أو خبرة سابقة أو تفسير خاطئ. والإيحاء الذاتي تعبير وصفي عن رسائل الفرد الداخلية وتوقعاته؛ وليس تصنيفًا علاجيًا واحدًا معتمدًا.

الخوف استجابة دفاعية مرتبطة بتهديد مدرك قريب أو حاد؛ أما القلق فيرتبط كثيرًا بإمكان وقوع تهديد بعيد أو غامض أو غير مؤكد. هذا تمييز وظيفي في إطار نطاقات معايير البحث في الصحة النفسية، لا قاعدة حاسمة تسمح بتشخيص فرد من عبارة واحدة (المعهد الوطني الأمريكي للصحة النفسية، دون تاريخ).

الإدراك المتحيز للتهديد ليس هو الكذب المتعمد؛ فالشخص قد يشعر بخوف حقيقي مع أن استدلاله على سبب الخوف غير مكتمل. وعلى العكس قد يكون الخطر موجودًا حتى إن لم يشعر الشخص بالخوف.

## جدول (1): تمييز المفاهيم الأساسية

| المفهوم | التمييز الإجرائي |
|---|---|
| الإيحاء | رسالة أو سياق قد يؤثر في التوقع أو السلوك، دون افتراض التحكم في الإرادة. |
| القابلية للإيحاء | تفاوت في الاستجابة للتأثيرات تبعًا للفرد والموقف، وليس تشخيصًا. |
| الخوف | استجابة لتهديد مدرك قريب أو حاضر. |
| القلق | استجابة مترقبة لخطر محتمل أو غامض. |
| التوقع | اعتقاد بشأن ما قد يحدث، قد يستند إلى دليل أو افتراض. |

## 3. أنماط الإيحاء ومصادره

الإيحاء اللفظي: التحذير أو التأكيد أو السؤال الموحّي أو الوصف المتكرر لنتيجة متوقعة؛ وقد يكون صادقًا ووقائيًا أو مضللًا. والإيحاء غير اللفظي: تعبيرات الوجه ونبرة الصوت وسلوك الهلع لدى المحيطين، على أن أثرها يتحدد بالسياق.

الإيحاء الاجتماعي: انتقال الرسائل بين الأسرة والأصدقاء والجماعات والمنصات الإعلامية. والإيحاء الذاتي: أحاديث الفرد الداخلية مثل «لن أتحمل» أو «سيحدث الشيء نفسه»؛ وهذه أمثلة تحليلية، وليست معادلات حتمية للخوف.

يجب عدم الخلط بين الإيحاء والتنويم الإيحائي؛ فالتنويم سياق محدد يبحث فيه أثر التوقعات والتعليمات، لكن تأثير الرسائل في الحياة اليومية أوسع منه، ولا تثبت الدراسات إمكان التحكم المطلق في الآخرين بالإيحاء (كيرش، 2023).

## 4. مسارات اكتساب الخوف: ما الذي تدعمه الأدبيات؟

عرض راشمان (1977) ثلاثة مسارات رئيسية لاكتساب الخوف: الخبرة المباشرة المقترنة بمثير منفّر، والتعلم بالملاحظة أو التعلم بالنيابة، وانتقال معلومات أو تعليمات تشير إلى الخطر. وهذا إطار تأسيسي لا يعني أن كل خوف يتبع أحد المسارات الثلاثة بصورة نقية.

الخبرة المباشرة: قد يرتبط مثير محايد بخبرة مؤلمة فينشأ خوف مكتسب. والتعلم بالملاحظة: قد يرى شخص آخر مذعورًا من موقف فيتعلم اعتبار الموقف مهددًا. والتعلم بالمعلومات: قد يكفي تحذير موثوق لتغيير التوقع والسلوك دون تجربة مباشرة.

توضح مراجعة أولسون وفيلبس (2007) أن التعلم الاجتماعي للخوف قد يجري عبر الملاحظة والتعليمات، مع اشتراك آليات عصبية مرتبطة

بالتعلم الدفاعي والتواصل الاجتماعي والذاكرة. ولا ينبغي تفسير النتائج باعتبارها إثباتًا أن الكلمات تنتج الخوف نفسه لدى جميع الأفراد.

## 5. العلاقة التبادلية: الإيحاء قد يولّد الخوف والخوف قد يعزز تأثير الرسالة

المسار الأول: رسالة تحذير ← توقع أذى ← انتباه إلى مؤشرات الخطر ← استجابة خوف أو قلق ← سلوك تجنب أو تحقق. وقد تكون الرسالة صحيحة تمامًا، أو مبالغًا فيها، أو كاذبة؛ لذا لا تُحسم الحقيقة من مجرد حدوث الاستجابة.

المسار الثاني: خوف قائم أو تجربة سابقة ← يقظة مرتفعة أو بحث انتقائي عن المعلومات المهددة ← زيادة بروز بعض التحذيرات وتفسيراتها ← تثبيت التوقع أو تعديله. هذا مسار تفسيري محتمل يتطلب اختبارًا في كل سياق؛ وليس حقيقة أن كل خائف قابل لتصديق كل إيحاء.

عندما يستمر التجنب قد يقل تعرض الفرد لمعلومات تصحح اعتقاده؛ وعندما يتكرر طلب الطمأنة قد يحدث ارتياح مؤقت، لكنه لا يزيل بالضرورة عدم اليقين. وقد يخف الخوف عند ظهور أدلة جديدة أو عند خبرة آمنة متكررة، شريطة ألا يكون هناك خطر واقعي يُغفل.

التمييز العلمي المطلوب: التأثير على إدراك الخطر ليس برهانًا على تغيّر الخطر نفسه؛ والتأثير على السلوك لا يثبت أن صاحب الرسالة قصد التلاعب.

## 6. ما يحدث في الدماغ والجسم

تشارك اللوزة الدماغية ومناطق الحُصين والفص الجبهي والجزيرة وشبكات الاستثارة في معالجة التهديد والتوقع والتعلم والتنظيم الانفعالي. ويمكن أن تُظهر الاستجابة الدفاعية تغيرات في ضربات القلب والتنفس والتعرق والانتباه، لكن لا توجد

«نقطة خوف» واحدة تفسر كل الحالات (أولسون وفيلبس، 2007؛ والمعهد الوطني الأمريكي للصحة النفسية، دون تاريخ).

يؤثر سياق التهديد ومدى قربه وإمكان السيطرة عليه في نوع الاستجابة. وقد تنشأ أحاسيس جسمية حقيقية بسبب التوقعات والاستثارة، ولا يعني كونها متأثرة بالعوامل النفسية أنها مختلقة.

المبالغة الشائعة التي يجب تجنبها: ليس صحيحًا أن كل رسالة سلبية تعيد برمجة الدماغ آليًا، ولا أن التفكير الإيجابي وحده يزيل جميع استجابات الخوف أو الأمراض.

## 7. النوسيبو والتوقعات السلبية

تأثير النوسيبو مصطلح بحثي يصف أعراضًا أو تفاقمًا سلبيًا يرتبط بسياق التدخل الصحي وتوقعاته، بما يتجاوز الأثر المباشر للتدخل. وتتداخل في تفسيره التوقعات السلبية والتعلم والسياق والتوتر، وهو ليس مرادفًا للتوهم أو للكذب.

بحث تحليل تلوي لروووني وزملائها العلاقة بين التوقعات والقلق وتأثير النوسيبو، وشمل 59 دراسة مستقلة. وأظهر ارتباط التوقعات السلبية والقلق ببعض آثار النوسيبو، مع الإقرار بتغاير الأدلة وحدود الاستدلال (روني وزملاؤه، 2023). كما تناولت مراجعة لاحقة نطاق التأثير عبر نتائج صحية مختلفة (روني وزملاؤه، 2024).

التطبيق الأخلاقي: في التواصل الطبي لا يجوز إخفاء المخاطر الجوهرية، لكن طريقة عرض الاحتمالات يجب أن تكون دقيقة وغير مهوّلة،

مع مراعاة موافقة المريض وحقه في المعرفة. ولا يجوز افتراض أن عرضًا صحيًا غير مشخص ناجم عن الإيحاء دون تقييم مناسب.

## 8. الإيحاء والخوف في العلاقات الإنسانية

قد يسمع فرد عبارة «عدم الرد السريع دليل على انعدام الحب» فيتبناها قاعدة قاطعة، ثم ينقل هذا التوقع إلى قراءة مواقف غامضة. وقد يزيد ذلك الاستجواب أو الاتهام أو الانسحاب، فينشأ توتر فعلي لا يثبت صحة الاعتقاد الأصلي.

لكن تفسير الغياب أو الصمت لا يكون دائمًا سوء فهم؛ فقد توجد وقائع موثقة من إهمال أو تضليل أو إساءة. لذلك تُقيّم العلاقات عبر أنماط السلوك المتكررة والتواصل المباشر والقرائن، لا عبر فكرة أن الإيحاء هو دائمًا السبب أو أن الشك دائمًا وهم.

مثال افتراضي: قالت صديقة لامرأة «كل من يطلب مساحة شخصية يخفي شيئًا». تتأثر المرأة بالتعميم. السؤال المناسب ليس «هل خوفها غير منطقي؟» بل «ما دليل التعميم؟ وما الواقعة الخاصة بهذه العلاقة؟ وما حدودها واتفاقاتها؟».

قد تكون اللغة المستخدمة في بعض العلاقات أسلوب ترهيب أو سيطرة قسرية؛ لكن تشخيص التعمد يحتاج قرائن مستقلة، ولا يُستنتج من الانطباع وحده.

## 9. التربية والمؤسسات والإعلام والصحة العامة

في التربية قد ينتقل خوف الكبار إلى الطفل من خلال التكرار والملاحظة، بينما يكون التحذير الموزون مطلوبًا في مواقف السلامة. المطلوب تعريف الخطر الحقيقي وتعليم طريقة التعامل معه بدل صناعة خوف شامل من العالم.

في بيئات العمل قد يؤدي الخطاب المستمر عن العقاب والفشل إلى ترقب وانسحاب أو كتمان للأخطاء. لكن بعض التحذيرات المهنية ضروري لضبط السلامة؛ ويُقاس الفرق بدقة الوقائع والتناسب وإمكان السؤال والاعتراض.

في الإعلام والمنصات الرقمية، يمكن لعرض القصص النادرة بصورة متكررة أن يرفع بروزها الذهني؛ ومع ذلك لا يصح استنتاج تغير احتمالات الخطر الواقعية دون بيانات مستقلة. ينصح بتقييم المصدر والإطار الزمني والاحتمال الأساسي وشدة الضرر.

في الصحة العامة يجب موازنة التحذير من المخاطر المؤكدة مع عدم تضخيم اليقين بشأن الأدلة المحدودة؛ فالتواصل المسؤول يصف قوة الدليل وحدوده.

## 10. التمييز بين التحذير والحذر والتخويف

التحذير المسؤول يقدم معلومات يمكن مراجعتها عن طبيعة الخطر واحتماله وشدته وإجراءات الحد منه؛ ولا يقصد انتزاع حرية القرار بالخوف وحده. أما التخويف المضلل فيعتمد تضخيم النتائج أو حجب السياق أو التهديد غير المتناسب.

ولا تكفي نبرة الشخص أو أثر كلماته في إثبات قصده. يجب التفريق بين صدق المعلومة، ودقة تقدير الخطر، وأثر الرسالة، والتعمد في استخدام الخوف. هذه أربعة أحكام مستقلة منطقيًا.

### جدول (2): الفروق العملية بين التحذير المسؤول والتخويف المضلل

| البعد | التحذير المسؤول | التخويف المضلل |
|---|---|---|
| الوقائع | | تُحجب أو تُقتطع |

| البعد | التحذير المسؤول | التخويف المضلل |
|---|---|---|
| | تُعرض مع مصدرها | |
| اليقين | يتناسب مع قوة الدليل | يُبالَغ فيه |
| الاستجابة | وقاية متناسبة | ضغط أو تهديد غير متناسب |

## 11. إطار YK7 الإجرائي المقترح للتحقق من الخوف

يُقترح إطار رباعي بوصفه أداة تنظيم للقراءة النقدية، وليس مقياسًا مقننًا أو نموذجًا عصبيًا مثبتًا: (1) الواقعة أو المثير: ماذا وقع ومتى؟ (2) التفسير: ما المعنى أو النية أو النتيجة التي نُسبت

إليه؟ (3) الاستجابة: ماذا شعر الفرد وماذا فعل؟ (4) التحقق: ما القرائن المؤيدة والمخالفة، وما مستوى الخطر، وما القرار المتناسب؟

ويرتبط هذا الإطار بمبدأ «صحة المجال»؛ فلا تُنقل قواعد التعامل مع الخطر الصحي إلى العلاقة العاطفية أو الإدارة أو القانون دون مراجعة شروط المجال. كذلك يجب الفصل بين واقع موثق، وتفسير محتمل، وفرضية تحتاج تحققًا، وسيناريو مستقبلي.

من مقتضيات الموازنة: ألا يتحول الإحساس إلى دليل وحيد، وألا يتحول الشك في الإيحاء إلى وسيلة لإنكار الوقائع، وألا يُستبدل القرار الرشيد برفض جميع التحذيرات.

## 12. مثال تحليلي مركب: من رسالة إلى قرار

الواقعة: تأخر رد شخص لساعات. الرسالة السابقة: «من يحب يرد فورًا». التفسير الأول: «التأخر يعني عدم الاهتمام». الاستجابة: توتر واتصالات متكررة واتهام. البدائل: انشغال، ظرف طارئ، تجنب مقصود، اختلاف في توقعات التواصل. التحقق: مراجعة نمط العلاقة والاتفاقات والسياق، مع سؤال مباشر غير اتهامي.

الأثر المحتمل: إذا كان التفسير الأول غير صحيح فقد يتحول الخوف إلى مصدر نزاع؛ وإذا كان هناك إهمال مستمر فقد يكشف التحقق عن مشكلة حقيقية. لا يقرر المثال أي النتيجتين، بل يوضح ضرورة الفصل بين الحدث والحكم عليه.

مثال صحي ثانٍ: شخص يسمع أن دواءً ما «سيسبب صداعًا حتميًا». قد تزيد مراقبة الأحاسيس والتوقعات السلبية، لكن الصداع قد

ينتج أيضًا عن أثر دوائي فعلي أو سبب مستقل. يظل التقييم الطبي المرجع لتحديد الحالة، لا افتراض النوسيبو.

## 13. معايير نقد الادعاءات والمعلومات

أولًا: دقة المصطلح؛ هل نتحدث عن إيحاء أو قلق أو تعلم ملاحظي أو توقع؟ ثانيًا: نوع الدليل؛ تجربة مضبوطة أم دراسة رصدية أم انطباع فردي؟ ثالثًا: السببية؛ هل فُحصت البدائل والعوامل المربكة؟ رابعًا: قابلية التعميم؛ هل يصلح الاستنتاج لهذه الفئة وهذا السياق؟

خامسًا: البعد الأخلاقي؛ هل توظف النتيجة لحماية الناس أم للسيطرة عليهم؟ سادسًا: حدود المعرفة؛ هل توجد نتائج متعارضة أو أمور لم تُختبر؟ سابعًا: العلاقة بالقرار؛ ما التدخل المتناسب مع مستوى الخطر؟

القابلية للإيحاء لا تُقاس بمثال عرضي، والأعراض لا تُشخّص بالمقال، والروايات الشخصية لا تتحول وحدها إلى إثبات علمي أو قانوني.

## 14. نتائج المراجعة ومستويات اليقين

نتيجة مدعومة بالأدبيات: يمكن أن يُكتسب بعض الخوف دون خبرة مؤذية مباشرة، عبر الملاحظة والمعلومات (راشمان، 1977؛ أولسون وفيلبس، 2007). نتيجة مدعومة في سياقات محددة: التوقعات السلبية تسهم في ظواهر نوسيبو صحية، مع تباين النتائج والآليات (روني وزملاؤه، 2023، 2024).

تفسير يحتاج تخصيصًا: الخوف القائم قد يوجّه الانتباه والتحقق من المعلومات، لكنه لا يثبت تلقائيًا زيادة عامة في القابلية للإيحاء. فرضية تطبيقية: قد تساعد أسئلة YK7 الرباعية على

تحسين الفصل بين الواقعة والتوقع في بعض المواقف؛ ولم تُختبر هذه الفرضية بعد بتجربة تقيس أثر الإطار.

الحكم النهائي: لا يجوز مساواة شدة الخوف بصحة دليل الخطر، ولا مساواة وجود إيحاء بانعدام الخطر. المعرفة المنضبطة تجمع بين الإصغاء للشعور والتحقق من الواقع وتحمل مسؤولية القرار.

## 15. الحدود والاعتبارات الأخلاقية والتطبيقية

الملف ليس دليلًا للتشخيص، ولا يغني عن تقييم مختص عند الخوف الشديد أو المستمر أو المعطل للأداء. في وجود عنف أو تهديد فعلي تكون أولوية السلامة والتوثيق وطلب المساعدة المختصة، لا اختبار ما إذا كان الخوف ناتجًا عن إيحاء.

لا يصح استخدام فكرة الإيحاء لاتهام شخص بأنه «ضعيف نفسيًا»، أو لاتهام طرف آخر بالتلاعب دون قرائن، أو لإقناع مريض بتجاهل أعراض جسدية. كما لا يجوز تطبيق مبادئ العلاج بالتعرض أو التنويم دون تأهيل مهني وحدود ممارسة واضحة.

ترتبط قيمة الملف بالتحقق من الأدلة ومراعاة السياق. وحدود المراجعة أنها سردية انتقائية؛ لذا فإن الادعاءات العامة عن حجم الآثار أو انتشارها تتطلب دراسات خاصة إضافية.

## المراجع العلمية وفق الإصدار السابع من دليل التوثيق

American Psychological Association. (n.d.). Suggestibility. APA Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org/suggestibility

Kirsch, I. (2023). Clinical hypnosis as a nondeceptive placebo: Empirically derived techniques. American Journal of Clinical Hypnosis, 65(3), 246–257. https://doi.org/10.1080/00029157.2022.2119023

National Institute of Mental Health. (n.d.-a). Acute threat (fear). https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/acute-threat-fear

National Institute of Mental Health. (n.d.-b). Potential threat (anxiety). https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/potential-threat-anxiety

Olsson, A., & Phelps, E. A. (2007). Social learning of fear. Nature Neuroscience, 10, 1095–1102. https://doi.org/10.1038/nn1968

Rachman, S. (1977). The conditioning theory of fear-acquisition: A critical examination. Behaviour Research and Therapy, 15(5), 375–387. https://doi.org/10.1016/0005-7967(77)90041-9

Rooney, T., Sharpe, L., Todd, J., Richmond, B., & Colagiuri, B. (2023). The relationship between expectancy, anxiety, and the nocebo effect: A systematic review and meta-analysis with recommendations for future research. Health Psychology Review, 17(4), 550–577. https://doi.org/10.1080/17437199.2022.2125894

Rooney, T., Sharpe, L., Todd, J., Tang, B., & Colagiuri, B. (2024). The nocebo effect across health outcomes: A systematic review and meta-analysis. Health Psychology, 43(1), 41–57. https://doi.org/10.1037/hea0001326

> توثيق الإصدار السابع من دليل الجمعية الأمريكية لعلم النفس يخص المصادر المنشورة؛ أما إطار YK7 فهو مقترح إجرائي من إعداد المؤلف وليس مقياسًا مقننًا.